ANÁLISIS INTEGRAL

Sistema POS y administración para una farmacia en Chile

Requisitos funcionales, normativa sanitaria, recetas, inventario, laboratorios, convenios, documentos tributarios, integraciones y arquitectura.

Objetivo del documento

Servir como base de levantamiento de requisitos y planificación para desarrollar un sistema de gestión farmacéutica. Distingue los módulos internos del software de las integraciones externas que requieren documentación, credenciales, convenios o certificación.

Jurisdicción: Chile
Fecha de elaboración: 24 de octubre de 2026
Estado: Documento de análisis; confirmar requisitos técnicos y legales antes de producción.

Nota: este documento no reemplaza asesoría legal, tributaria ni sanitaria. Las obligaciones deben validarse con el contador, el director técnico de la farmacia y los organismos competentes.

1. Resumen ejecutivo

Una farmacia necesita mucho más que un POS con inventario. El sistema debe conectar ventas, productos farmacéuticos, presentaciones, lotes, vencimientos, compras, recetas, dispensaciones, documentos tributarios, pagos, convenios, seguridad y reportes.

Las cinco decisiones críticas son:

- Tributación: integrar la emisión de documentos electrónicos mediante un flujo que cumpla las especificaciones y certificación aplicables del SII.
- Regulación sanitaria: manejar condiciones de venta, recetas simples, retenidas, cheque y medicamentos controlados con reglas específicas.
- Catálogo: separar principio activo, producto autorizado, presentación, laboratorio, titular del registro, proveedor y lote.
- Convenios: no asumir que existe una API universal para descuentos por RUT; cada programa requiere confirmación y condiciones propias.
- Privacidad: aplicar controles estrictos a recetas y datos de pacientes, teniendo presente la entrada en vigor de la Ley 21.719 el 1 de diciembre de 2026.

El objetivo de trazabilidad es poder explicar qué se vendió, de qué lote salió, a qué costo se adquirió, bajo qué condiciones se dispensó, qué beneficio se aplicó, cómo se cobró y qué documento tributario respalda la operación.

2. Marco normativo y organismos

Organismos que deben considerarse:

Organismo / norma	Relevancia para el sistema
Ministerio de Salud (MINSAL)	Receta electrónica, normativa sanitaria y dispensación.
Instituto de Salud Pública (ISP)	Registros sanitarios, bioequivalencia, medicamentos controlados y fiscalización.
Servicio de Impuestos Internos (SII)	Boletas, facturas, notas de crédito y documentos tributarios electrónicos.
CENABAST	Abastecimiento y precios máximos aplicables a productos bajo la Ley Cenabast.
SEREMI de Salud	Autorización y fiscalización de establecimientos farmacéuticos.
DS 466, Reglamento de Farmacias	Reglas de expendio, recetas y condiciones sanitarias.
Ley 21.719	Reforma de protección de datos personales; entrada en vigor prevista para el 1 de diciembre de 2026.

La implementación informática no sustituye la autorización sanitaria ni las obligaciones del director técnico. Las reglas exactas deben validarse con la normativa vigente, el químico farmacéutico responsable y los asesores tributarios.

Fuentes oficiales para consultar:

- Decreto Supremo 466 — Reglamento de Farmacias
- ISP — Consulta de registros sanitarios
- SII — Documentación técnica de boleta electrónica
- MINSAL — Sistema Nacional de Receta Electrónica
- CENABAST — Ley Cenabast
- Biblioteca del Congreso Nacional — Legislación chilena

3. Flujo operativo de una farmacia

Etapa	Procesos y datos que deben quedar registrados
1. Compra	Orden de compra, proveedor, precios pactados, condiciones comerciales y documento de compra.
2. Recepción	Cantidades recibidas, diferencias, lotes, vencimientos, costo y sucursal.
3. Almacenamiento	Ubicación, condiciones de conservación, stock disponible, cuarentena cuando corresponda.
4. Venta y dispensación	Producto, precio, receta, restricciones, lote entregado, beneficio y responsable.
5. Cobro y tributación	Medios de pago, boleta/factura, estado de emisión y conciliación.
6. Administración	Cierre de caja, márgenes, reposición, vencimientos, cuentas por pagar y auditoría.

Las operaciones deben ser consistentes. Una venta debe vincularse con sus líneas, pagos, movimientos de inventario, lote dispensado, receta si corresponde y documento tributario. Los fallos parciales deben poder detectarse y resolverse sin duplicar cobros o emisiones.

4. Catálogo farmacéutico y estructura de productos

4.1. Jerarquía correcta

- Principio activo / DCI: sustancia farmacológica; no identifica por sí sola un producto comercial.
- Producto farmacéutico: medicamento autorizado, con concentración, forma farmacéutica, vía y registro sanitario.
- Presentación comercial: caja, frasco, blíster, volumen o cantidad de unidades por envase.
- Lote: partida recibida con fecha de vencimiento, costo y trazabilidad propios.

4.2. Campos recomendados

Grupo	Campos
Identificación	SKU interno, EAN/GTIN, nombre comercial, descripción y estado activo.
Farmacología	Principio activo/DCI, concentración, forma farmacéutica y vía.
Presentación	Unidades por envase, contenido neto, volumen/peso y unidad comercial.
Registro sanitario	Número, estado, titular y clasificación regulatoria aplicable.
Laboratorio	Fabricante, titular del registro, marca e importador cuando corresponda.
Dispensación	Venta directa, receta simple, receta retenida, receta cheque y restricciones.
Almacenamiento	Temperatura, cadena de frío y condiciones especiales.
Comercial	Costo, precio, margen, impuestos aplicables y listas de precios.
Abastecimiento	Proveedores, códigos de proveedor, plazo de entrega y condiciones.
Trazabilidad	Lotes, vencimientos, movimientos, devoluciones, cuarentena y retiros.

4.3. Laboratorio, titular y proveedor

No son conceptos intercambiables. Un producto puede fabricarse por un laboratorio, tener otro titular de registro y comprarse a varios distribuidores. La base de datos debe admitir múltiples proveedores por producto y múltiples productos por proveedor. Esto permite comparar costos, negociar compras y mantener continuidad de abastecimiento.

4.4. Dosis y unidades

Separar concentración/potencia, presentación comercial y posología prescrita. Manejar unidades como comprimido, cápsula, frasco, mL, g, sobre, ampolla, unidad y envase, con conversiones explícitas y controladas. No permitir conversiones incompatibles ni fraccionar envases por defecto: la dispensación debe respetar la normativa y las condiciones del producto.

5. Inventario, lotes y vencimientos

Funcionalidad	Requisito
Stock por sucursal	Existencias independientes por local y bodega.
Stock por lote	Trazabilidad de partida, vencimiento, ubicación y cantidad.
Vencimientos	Alertas configurables, por ejemplo 180, 90, 60 y 30 días.
FEFO	Priorizar el lote con vencimiento más cercano cuando corresponda.
Mínimos y máximos	Alertas de reposición por demanda y plazo del proveedor.
Conteos físicos	Inventarios, diferencias y ajustes con autorización.
Transferencias	Salida, traslado y recepción entre sucursales.
Dañados / cuarentena	Separación de existencias no vendibles y disposición autorizada.
Retiro del mercado	Bloquear venta y localizar lotes afectados.
Cadena de frío	Registrar condiciones y controles cuando corresponda.
Devoluciones	Evaluar antes de reingresar al stock comercializable.
Historial	Movimientos con usuario, motivo, fecha y documento relacionado.

5.1. Recepción de compras

- Crear orden de compra al proveedor.
- Registrar recepción real y compararla con la orden.
- Identificar productos, cantidades, lotes, vencimientos y costos.
- Comparar factura y recepción; registrar discrepancias.
- Actualizar stock y costos mediante movimientos auditables.
- Programar pagos y actualizar cuentas por pagar.

Las facturas de proveedores no siempre incluyen lotes y vencimientos. El sistema debe permitir capturarlos en la recepción y no asumir que se obtendrán automáticamente del documento tributario.

5.2. Reposición inteligente

Calcular recomendaciones considerando ventas históricas, estacionalidad, stock disponible, compromisos, vencimientos y plazo de entrega. Indicadores sugeridos: rotación, días de inventario, margen bruto, quiebres de stock y productos inmovilizados.

6. Recetas y dispensación

6.1. Condiciones de venta

Código / categoría	Comportamiento del sistema
VD — Venta directa	No exigir receta por defecto; respetar restricciones del producto.
R — Receta simple	Exigir y verificar receta conforme a las reglas aplicables.
RR — Receta retenida	Aplicar el procedimiento de retención, archivo o registro correspondiente.
RCH — Receta cheque	Aplicar restricciones y procedimientos especiales para productos sujetos a receta cheque.

La condición debe provenir de la clasificación regulatoria del producto, no inferirse solamente a partir del nombre o principio activo.

6.2. Registro de dispensación

- Identificador o folio de receta y fuente (electrónica o física).
- Tipo de receta, estado de validación y condición de retención.
- Identificación del prescriptor y del paciente cuando sea exigible.
- Medicamento, cantidad prescrita y cantidad entregada.
- Fecha, hora, usuario responsable y sucursal.
- Dispensaciones parciales y saldo pendiente cuando proceda.
- Vínculos con venta, lote, pago y documento tributario.

6.3. Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE)

El MINSAL lanzó el Sistema Nacional de Receta Electrónica en diciembre de 2025. La documentación ministerial ha descrito interoperabilidad y componentes técnicos asociados a HL7 FHIR, pero debe distinguirse esa arquitectura de la disponibilidad de una API abierta para cualquier desarrollador.

- Solicitar al MINSAL requisitos actuales para dispensadores privados.
- Confirmar documentación técnica, credenciales, certificación y condiciones de acceso.
- Diseñar un módulo de recetas desacoplado del POS.
- Preparar un adaptador de integración; no inventar endpoints ni dar por garantizado el acceso.
- Definir un flujo operativo compatible con la plataforma oficial mientras se confirma la integración.

6.4. Medicamentos controlados

Los estupefacientes y psicotrópicos tienen requisitos adicionales. El ISP señala, entre otras normas, los decretos 404 y 405. El sistema debe apoyar el cumplimiento de los procedimientos de control y trazabilidad que correspondan a cada categoría.

- Identificar productos sujetos a control legal.
- Registrar ingresos, egresos, lotes, saldos y responsables.
- Asociar dispensaciones con receta y usuario autorizado.
- Restringir funciones mediante permisos específicos.
- Generar alertas de diferencias y movimientos inusuales.
- Apoyar reportes y procedimientos de pérdida, robo, baja o destrucción según las reglas vigentes.

6.5. Bioequivalencia y sustitución

El catálogo puede relacionar alternativas bioequivalentes, pero no debe sustituir automáticamente un producto solo porque comparte principio activo. Deben comprobarse los criterios de equivalencia, concentración, forma farmacéutica, presentación y condiciones normativas; la decisión debe respetar las atribuciones profesionales aplicables.

7. Convenios, descuentos por RUT y programas

7.1. Convenios privados

Puede haber acuerdos con aseguradoras, instituciones de salud, cajas de compensación, empresas, laboratorios u operadores de beneficios. Las reglas varían: elegibilidad, vigencia, productos incluidos, límites, copagos, acumulación, liquidación y método de validación.

No se identificó una API pública universal chilena que consulte todos los convenios por RUT. Cada integración debe confirmarse con el titular del programa. No se debe inferir un beneficio por género, afiliación o condición de salud a partir del RUT.

7.2. Ley Cenabast

La Ley 21.198 permite abastecer a farmacias privadas adheridas con precios máximos para los productos incluidos en la modalidad. El precio máximo aplica a los productos efectivamente cubiertos y abastecidos bajo el programa, no automáticamente a todas las marcas con el mismo principio activo.

- Registrar la adhesión de la farmacia y la vigencia de la canasta.
- Identificar productos y presentaciones incluidos.
- Relacionar compras, costos, lotes y existencias.
- Controlar el precio máximo aplicable y alertar ante posibles incumplimientos.
- Separar el origen de existencias cuando sea necesario para cumplir las reglas del programa.

7.3. Motor de beneficios

Campo	Uso
Convenio	Entidad responsable y nombre del acuerdo.
Elegibilidad	RUT, código de afiliación u otro mecanismo autorizado.
Productos	SKU, categorías o listado específico del programa.
Beneficio	Porcentaje, precio pactado, monto fijo o copago.
Vigencia	Fechas de inicio y término.
Límites	Máximo por transacción, paciente o período.
Acumulación	Compatibilidad con promociones y otros descuentos.
Validación	API, portal externo o proceso manual autorizado.
Auditoría	Respuesta, fecha, usuario, importe y motivo.
Liquidación	Monto por recuperar y documentos necesarios.

Distinguir precio de lista, promoción, descuento financiado por la farmacia y beneficio financiado por terceros.

8. POS y documentos tributarios electrónicos

8.1. SII y documentación

El SII publica documentación técnica para boletas electrónicas y facturación electrónica. Un desarrollo propio debe cumplir el procedimiento de certificación y las exigencias técnicas vigentes. La aplicación gratuita del SII no se integra directamente con el POS.

- Documentación técnica de Boleta Electrónica
- Boleta electrónica y comprobantes de pago
- Portal de Facturación Electrónica

Documento / proceso	Propósito
Boleta electrónica	Venta a consumidor final conforme al modelo declarado.
Factura electrónica	Venta a clientes para quienes corresponda facturar.
Nota de crédito	Anulación o corrección cuando corresponda.
Nota de débito	Ajustes tributarios legalmente procedentes.
Guía de despacho	Cuando la operación y normativa lo exijan.
Estado de envío	Conservar respuesta y estado del documento.
Consulta de estado	Resolver emisiones con resultado incierto.

8.2. Voucher versus boleta

El SII contempla modelos donde el comprobante de pago electrónico de un operador autorizado puede servir como boleta, bajo las condiciones aplicables. También existe la modalidad de emitir siempre la boleta además del voucher. Debe confirmarse y configurarse el modelo declarado por la farmacia.

- Confirmar modelo tributario con contador y SII.
- Identificar operador de pago y tipos de transacción.
- Definir el tratamiento de pagos mixtos, efectivo, transferencias y tarjetas.
- Evitar duplicar documentos para una misma operación.
- Conciliar ventas, pagos, documentos y Registro de Compras y Ventas.

8.3. Estados, reintentos y contingencias

Cada documento debe registrar ID interno, tipo, folio cuando corresponda, importe, fecha, datos de emisión, estado de envío y respuesta del SII. Estados sugeridos: pendiente, enviado, aceptado/validado, rechazado, resultado desconocido pendiente de consulta y corregido/anulado mediante documento relacionado.

Ante una respuesta incierta, consultar el estado antes de reenviar para evitar duplicados, según las capacidades documentadas del servicio. No marcar como aceptado un documento sin confirmación.

8.4. Devoluciones

No eliminar ventas que ya tengan documento tributario emitido. Registrar la devolución o corrección como una operación vinculada y emitir la documentación exigible. La devolución del dinero no implica automáticamente que el medicamento pueda volver al stock comercializable.

9. Matriz de APIs e integraciones

Sistema	Estado conocido	Acción recomendada
SII — Boleta	Documentación técnica oficial disponible.	Estudiar formatos, autenticación, estados y certificación.
SII — Factura	Documentación oficial disponible.	Implementar documentos que correspondan mediante proceso autorizado.
MINSAL — SNRE	Plataforma nacional y arquitectura de interoperabilidad descritas; API pública abierta no confirmada.	Solicitar requisitos, credenciales y acceso para dispensadores privados.
ISP — Registro sanitario	Consulta pública; API general no confirmada.	Confirmar método autorizado para actualización de catálogo.
CENABAST	Portal y canastas; API pública general para POS no confirmada.	Consultar condiciones de adhesión e integración.
Isapres / aseguradoras	No hay servicio universal identificado.	Consultar cada entidad por convenio y documentación técnica.
Laboratorios / programas	Depende del programa.	Solicitar contrato, reglas, endpoints y credenciales.
Operador de pagos	Depende del proveedor contratado.	Elegir proveedor y obtener documentación de terminal/API.

No comprometer integraciones en un precio cerrado antes de confirmar disponibilidad, certificación, convenios, credenciales y soporte de terceros.

10. Administración y reportes

Módulo	Funciones
Compras y proveedores	Órdenes, listas de precios, comparación de costos, recepción, facturas, notas de crédito, pagos y cuentas por pagar.
Caja y finanzas	Apertura/cierre, fondos, arqueo, ingresos/egresos autorizados, diferencias, pagos y conciliación.
Precios y promociones	Precios por sucursal, vigencias, margen mínimo, promociones, convenios y topes regulatorios.
Usuarios y permisos	Roles de cajero, químico farmacéutico, bodega, comprador, administrador y contador; permisos por sucursal.
Reportes	Ventas, margen, rotación, vencimientos, pérdidas, inventario, proveedores, convenios y sucursales.
Auditoría	Cambios de precios, anulaciones, descuentos, ajustes de stock, accesos y exportaciones.

Indicadores recomendados

- Venta bruta, descuentos, devoluciones y venta neta.
- Margen bruto por producto, categoría, laboratorio y sucursal.
- Compras pendientes de recepción y facturas por pagar.
- Productos próximos a vencer y pérdidas registradas.
- Días de inventario, rotación y quiebres de stock.
- Ventas por cajero, turno y medio de pago.
- Valor del inventario al costo y al precio de venta.
- Convenios aplicados, importes por recuperar y beneficios rechazados.

- Diferencias de caja y movimientos extraordinarios.

No confundir ventas, dinero recibido, margen y cuentas por cobrar. Los informes financieros deben separar estos conceptos.

11. Seguridad y privacidad

Las recetas, los datos de pacientes, los RUT y los historiales de dispensación pueden revelar información sensible. Deben aplicarse controles adecuados a la Ley 19.628, a la reforma de la Ley 21.719 y a las normas sanitarias aplicables. La Ley 21.719 tiene entrada en vigor prevista para el 1 de diciembre de 2026; verificar su vigencia y disposiciones aplicables al desplegar el sistema.

- Acceso por roles y principio de privilegio mínimo.
- Autenticación robusta para cuentas administrativas.
- Cifrado de comunicaciones y protección de datos almacenados.
- Bitácora de acceso y cambios sobre recetas y operaciones sensibles.
- Respaldos separados de la base principal y pruebas de restauración.
- Plan de recuperación ante incidentes.
- Control de exportación y descarga de información.
- Reglas de conservación y eliminación según obligaciones legales.
- Base jurídica y autorizaciones adecuadas para cada finalidad.
- Separar datos necesarios para dispensación de los usados para marketing.

El RUT no es una contraseña ni prueba por sí solo identidad, afiliación o elegibilidad. Solicitarlo solo cuando exista una razón legítima y documentada.

12. Arquitectura técnica de referencia

Para una farmacia independiente, una aplicación modular sobre una base relacional es un buen punto de partida; no es necesario dividir todo en microservicios desde el inicio.

Componente	Responsabilidad
POS / caja	Venta, pagos, descuentos, turnos y devoluciones.
Administración web	Productos, proveedores, compras, precios, usuarios e informes.
Módulo de recetas	Validación, registro de dispensación y reglas sanitarias.
Inventario	Lotes, vencimientos, movimientos, transferencias y conteos.
Backend / API interna	Reglas de negocio, transacciones, permisos y validaciones.
Base de datos	Integridad relacional y persistencia de ventas, lotes y documentos.
Auditoría	Historial de operaciones sensibles y cambios.
Adaptadores externos	SII, SNRE, pagos, convenios y fuentes de catálogo.
Reportes	Indicadores y exportaciones autorizadas.

Principios técnicos

- Usar una base relacional robusta como PostgreSQL, con claves foráneas, transacciones y restricciones de integridad.
- Separar módulos y reglas de negocio.
- Aislar integraciones externas mediante adaptadores.

- No modificar stock silenciosamente: cada cambio crea un movimiento auditable.
- Preparar estructura multisucursal aunque inicialmente exista un solo local.
- Relacionar cada documento tributario con su venta y respuesta del SII.
- Definir contingencias para cortes de Internet, SII, SNRE y operador de pagos.
- No implementar emisión offline sin confirmar las condiciones legales y técnicas.

13. Plan de implementación

Fase	Entregables principales
1. Levantamiento	Procesos del local, roles, catálogo, proveedores, cajas, convenios y requisitos tributarios.
2. Catálogo e inventario	Productos, presentaciones, proveedores, lotes, vencimientos, recepción y transferencias.
3. POS y tributación	Ventas, precios, pagos, caja, devoluciones, documentos tributarios y certificación.
4. Recetas y regulación	Condiciones de venta, recetas, dispensaciones y controles de productos regulados.
5. Convenios y automatización	Integraciones con acceso confirmado, beneficios y reposición inteligente.
6. Validación y expansión	Pruebas, auditoría, respaldos, reportes y preparación multisucursal.

Pruebas de aceptación

- Venta con varios productos y distintos medios de pago.
- Documento tributario sin respuesta inmediata del SII.
- Corrección o anulación de una boleta.
- Producto con múltiples proveedores y costos.
- Dos lotes con vencimientos diferentes.
- Venta de medicamento sujeto a receta sin receta válida.
- Dispensación parcial cuando esté legalmente permitida.
- Producto controlado con autorización inválida o insuficiente.
- Descuento a beneficiario no elegible.
- Dos ventas simultáneas de las últimas unidades.
- Devolución de producto no apto para reingreso al stock.
- Usuario sin permisos que intenta cambiar precios, borrar movimientos o acceder a recetas.

14. Checklist de levantamiento con el dueño

- ¿Cuántas sucursales y bodegas tiene la farmacia?
- ¿Qué software utiliza y qué información se debe migrar?
- ¿Vende medicamentos controlados o productos refrigerados?
- ¿Utiliza actualmente el Sistema Nacional de Receta Electrónica?
- ¿Cómo emite boletas y facturas hoy?
- ¿Qué terminales u operadores de pago utiliza?
- ¿Con qué laboratorios, mayoristas y distribuidores trabaja?
- ¿Qué convenios y programas de descuento utiliza?
- ¿Está adherida a la Ley Cenabast?

- ¿Necesita venta por Internet o despacho a domicilio?
- ¿Necesita cuentas corrientes o ventas a empresas?
- ¿Quién será el director técnico y quién valida los procedimientos regulatorios?

15. Recomendación final

Desarrollar un ERP especializado en farmacia con POS integrado, en lugar de un POS genérico al que luego se agreguen campos farmacéuticos.

- Prioridad 1: modelo correcto de productos, presentaciones, laboratorios, proveedores, lotes y vencimientos.
- Prioridad 2: capa tributaria independiente, validada para el escenario real y con manejo de estados y contingencias.
- Prioridad 3: módulo regulatorio para recetas, dispensaciones y productos sometidos a control legal.
- Prioridad 4: compras, finanzas, convenios, reportes, seguridad y soporte multisucursal.

Antes de fijar precio o plazo, confirmar la documentación de integración del SII, las condiciones técnicas del MINSAL y los procesos de dispensación con el director técnico. Las integraciones de terceros no deben darse por disponibles hasta que sus responsables lo confirmen.

La trazabilidad completa debe permitir responder: qué se vendió, de qué lote salió, a qué costo se compró, bajo qué condiciones se dispensó, qué beneficio se aplicó, cómo se cobró y qué documento tributario respalda la operación.

Anexo A. Fuentes oficiales de referencia

- SII — Instructivo técnico de boleta electrónica
- SII — Boleta electrónica y voucher
- SII — Facturación electrónica
- MINSAL — Sistema Nacional de Receta Electrónica
- ISP — Registro sanitario de productos farmacéuticos
- CENABAST — Ley Cenabast
- CENABAST — Portal para farmacias adheridas
- BCN — Decreto Supremo 466
- BCN — Biblioteca de legislación chilena

Nota de verificación: los portales y normas pueden cambiar. Este documento resume el análisis y los puntos de integración identificados al 24 de octubre de 2026; antes de producción, confirmar la versión vigente de cada norma, la disponibilidad real de API, sus condiciones de acceso y la documentación técnica oficial.